



אבחנת דופק – מבוא

שיטת מישוש ואבחנת הדופק היא מהמהותיות והמורכבות שבשיטות האבחון הסיני.

מקורות: LI SHI ZEN · MACIOCIA · תרגום: קרן סצ'י

מדוע הדופק חשוב?

אתגר סובייקטיבי

שיטה עדינה ביותר, נתונה להשפעות
חיצוניות קצרות טווח – ולכן קשה ללימוד
ולפרשנות.

תמונה כוללת

משקף את מכלול הצ'י, הדם, היין, היאנג –
ואפילו את המזג האישי.

מידע מפורט

מספק אינדיקציות על מצב האיברים
הפנימיים.



לדוגמה: ריצה במדרגות, טראומה רגשית, או שינה מועטה – כולן ישנו את הדופק זמנית, ללא קשר לפתולוגיה.

רקע היסטורי

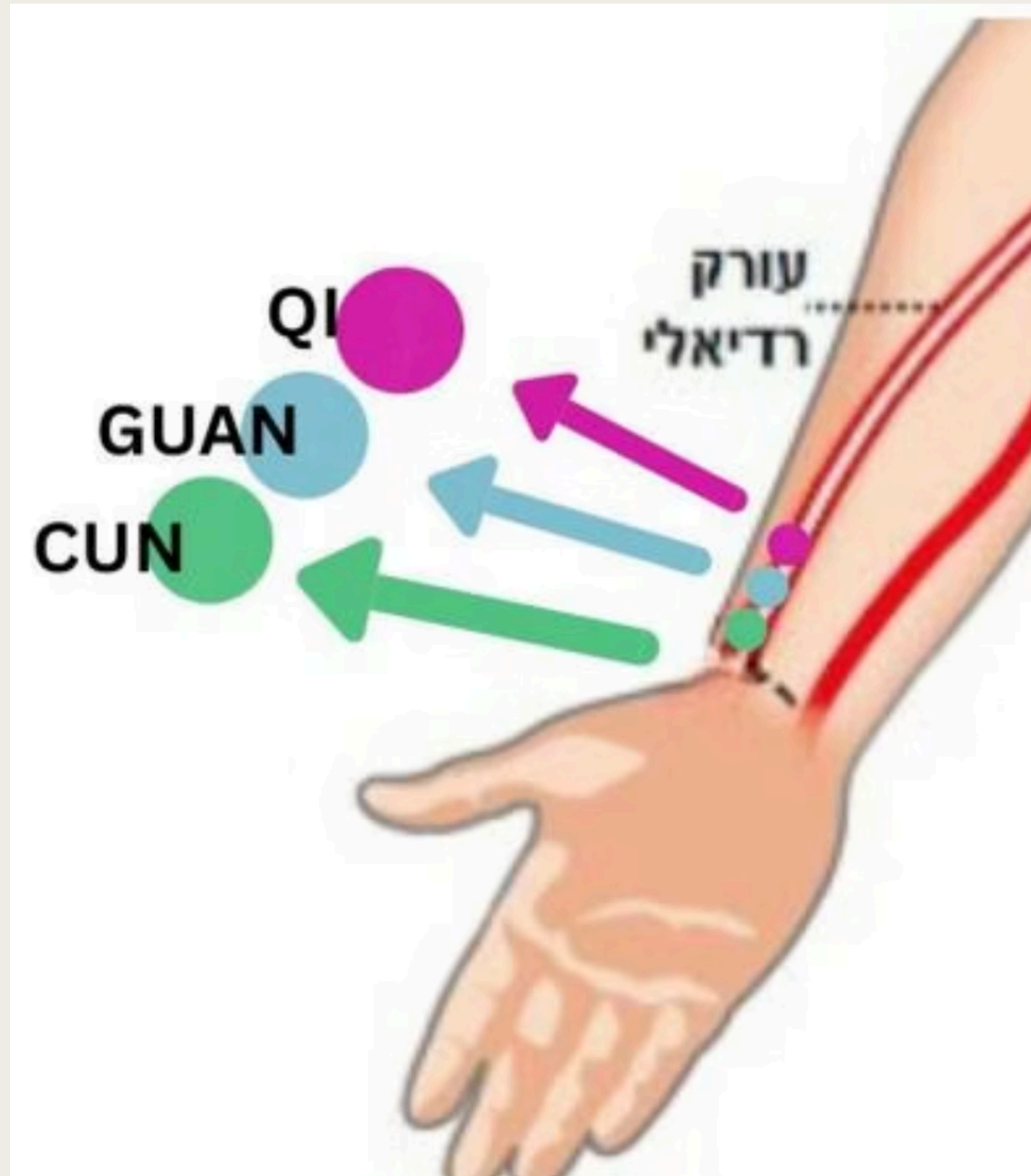
לפני "קלאסיקת הקשיים" נמדד הדופק ב־**תשעה עורקים** – שלושה בראש, שלושה בידים, שלושה ברגליים – המשקפים את שלושת המחממים.

Table 25.1 The nine regions of the pulse from the ‘Simple Questions’					
Area	Location	Region	Point	Organ or body part	Alternative
Upper	Head	Upper Middle Lower	Tai Yang ST-3 Juliao T.B.-21 Ermen	Qi of head Qi of mouth Qi of ears and eyes	
Middle	Hand	Upper Middle Lower	LU-8 Jingqu L.I.-4 Hegu HE-7 Shenmen	Lungs Centre of thorax Heart	
Lower	Leg	Upper Middle Lower	LIV-10 Wuli KI-3 Taixi SP-11 Jimen	Liver Kidneys Spleen and Stomach	LIV-3 Taichong ST-42 Chongyang

"קלאסיקת הקשיים" (כ־100 לספירה) קבעה את הנוהג למדוד את הדופק **בעורק הרדיאלי בלבד**, בנקודת LU-9 – "שער האינץ'" – המשקפת את כל חמשת איברי היין ושישת איברי היאנג.

"שער האינץ'" הוא נקודת ההתחלה והסיום של האנרגיה של חמשת איברי היין ושישה איברי היאנג, ולכן ניתן למדוד את הדופק רק בנקודה זו.

שלושת המקטעים ותשעת האזורים



הדופק בעורק הרדיאלי
מחולק לשלושה מקטעים:

כל מקטע נמדד בשלושה עומקים –

שטחי, אמצעי ועמוק – ויוצר את **תשעת**

האזורים.

צ'י (QI) – אחורי
מחמם תחתון • טבור עד כפות הרגליים

גואן (GUAN) – אמצעי
מחמם אמצעי • סרעפת עד טבור

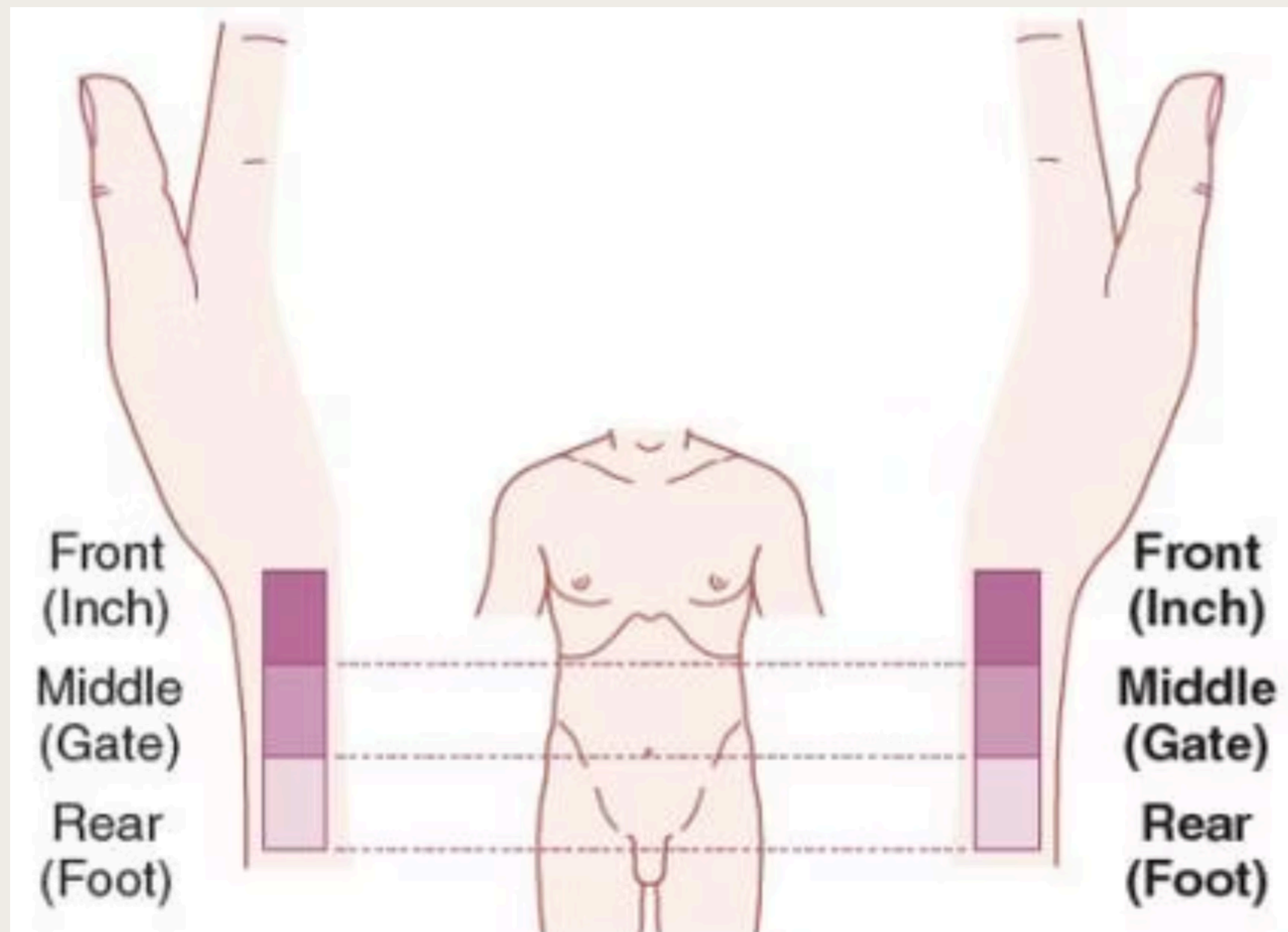
צון (CUN) – קדמי
מחמם עליון • חזה עד ראש

שיוך האיברים למיקומי הדופק

קיימת הסכמה כללית:
עמדות קדמיות = מחמם עליון,
אמצעיות = מחמם אמצעי,
אחוריות = מחמם תחתון.

הסתירות העיקריות נוגעות לאיברי היאנג –
ובמיוחד למיקום המעי הגס והמעי הדק. חלק
מהרופאים כלל לא ייחסו לאיברי יאנג ביטוי
בדופק.

המיקום האחורי הימני: "קלאסיקת
הקשיים" מייחסת אותו לשלושת
המחממים וקרומ הלב; קלאסיקות
מאוחרות – לכליות ומחמם תחתון.



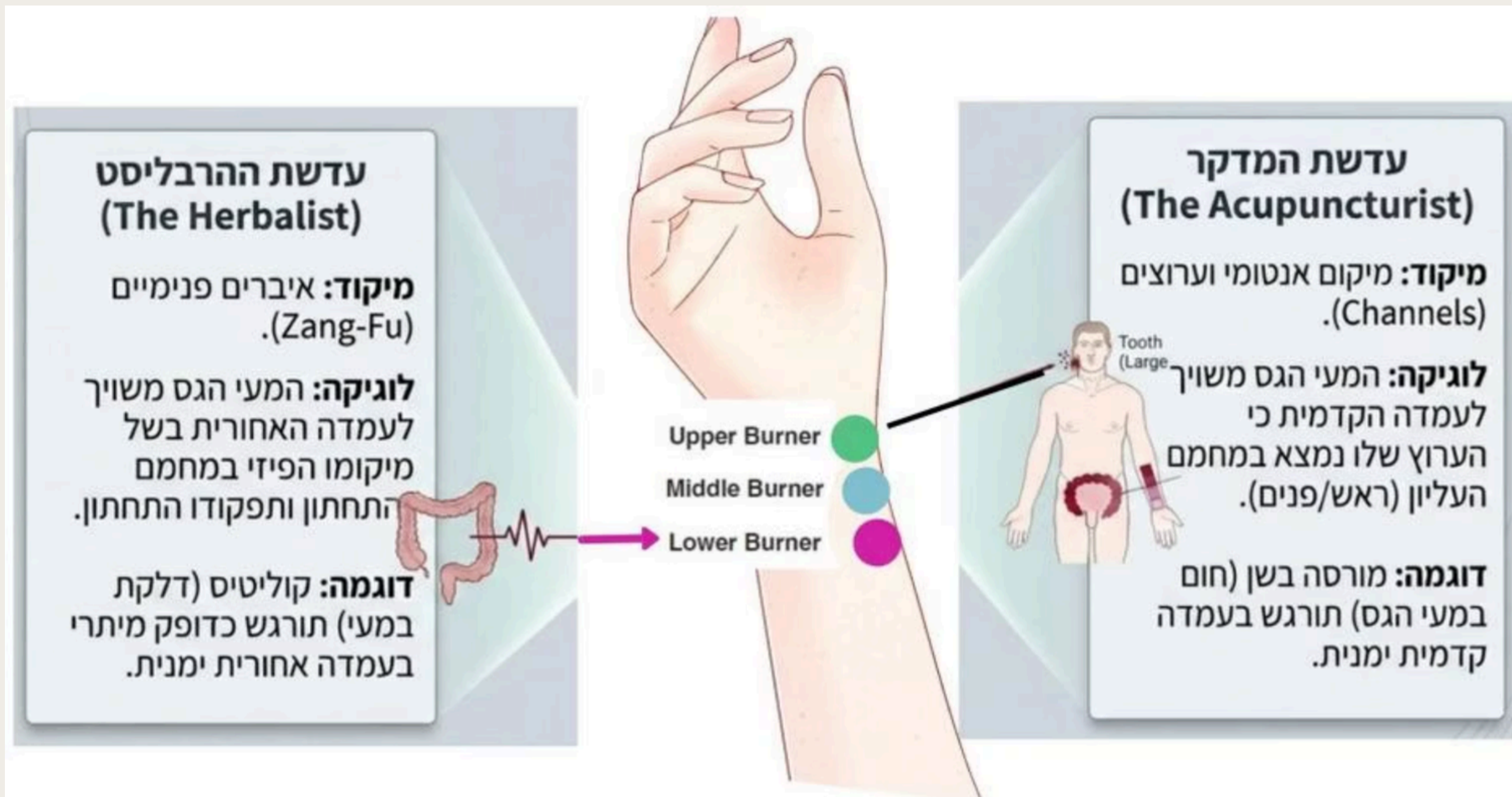
עדשת ההרבליסט לעומת עדשת המדקר

ההרבליסט

מתמקד באיברים פנימיים (Zang-Fu).
המעיהגס – עמדה אחורית ימנית
(מחמם תחתון).
דוגמה: קוליטיס → דופק מיתרי אחורי ימני.

המדקר

מתמקד בערוצים (Channels). המעיהגס
– עמדה קדמית ימנית (ערוץ במחמם
עליון).
דוגמה: מורסה בשן → דופק מלא קדמי
ימני.



המשמעות הקלינית של מיקומי הדופק

עמדה קדמית – שמיים

מחמם עליון. משקף מחלות מהחזה ועד הראש.

עמדה אמצעית – אדם

מחמם אמצעי. משקף מחלות בין הסרעפת לטבור.

עמדה אחורית – אדמה

מחמם תחתון. משקף מחלות מהטבור ועד כפות הרגליים.



הדבר החשוב ביותר: להעריך את זרימת הצ'י, יחס יין-יאנג, עומק הדופק, ונוכחות גורם פתוגני חיצוני – לא רק מיקום מכני.

איבר לעומת ערוץ – דוגמה קלינית

הדופק האמצעי השמאלי (מיקום הכבד) ממחיש כיצד אותו מיקום יכול לשקף תופעות שונות:

3

מורסה בשן

דופק קדמי ימני מלא – משקף ערוץ המעי הגס, לא בעיה בריאות.

2

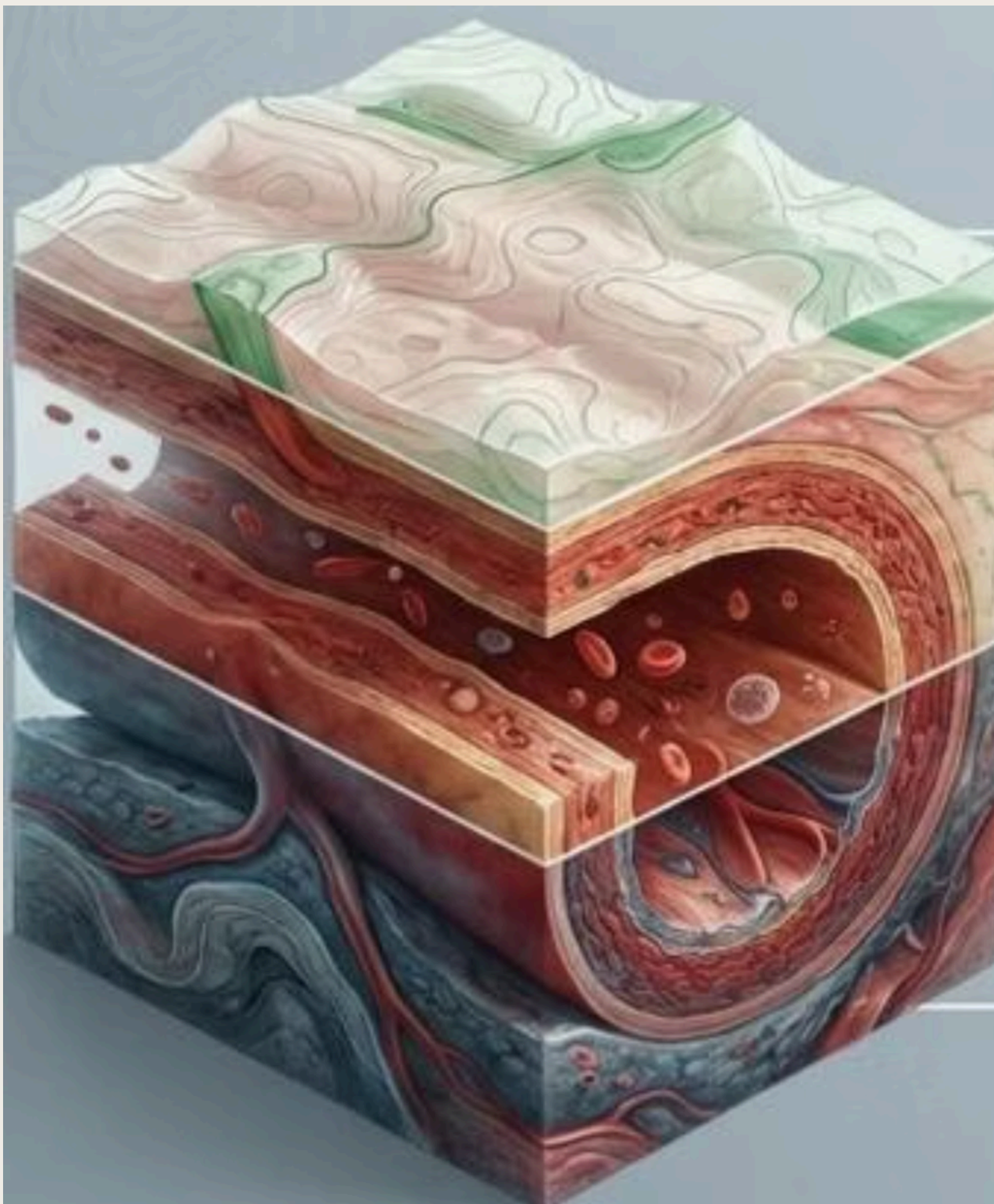
יאנג כבד עולה

דופק מתוח ושטחי – צ"י כיס המרה בעודף, כאבי ראש ברקה.

1

בראות

דופק רך ורגוע – יין ויאנג מאוזנים בתחום הכבד.



שלוש רמות העומק

שטחית – מגע עדין

אנרגיה: צ'י ואיברי Yang.
מחלות חיצוניות, לב וריאות.

אמצעית – לחיצה מתונה

אנרגיה: דם.
מחלות קיבה וטחול.

עמוקה – לחיצה חזקה

אנרגיה: יין ואיברי Yin.
מחלות פנימיות, כליות.

לי שייג'ו מוסיף: שטחית = לב וריאות; אמצעית =
קיבה וטחול; עמוקה = כבד וכליות.



סיכום – עקרונות מנחים



שלושה מקטעים

קדמי, אמצעי, אחורי – משקפים את שלושת המחממים.



שלוש רמות עומק

שטחי = צ', אמצעי = דם, עמוק = יין.



פרשנות דינמית

אין לפרש מכנית – יש להעריך את זרימת הצ'י ויחס יין-יאנג בכללותם.



הרבליסט vs. מדקר

גישות שונות – שתיהן תקפות, משקפות מוקד טיפולי שונה.